2026 総合医療・地域医療学 試験対策

Nov 2, 2026 ・ @谷風操縦士

0. 試験の形式

項目	内容（2026年11月2日 四方教授スライドより）
配点	100点満点、60点未満は不可 → 再試験（論述式もしくは口頭試問）
論述式	1問・40%。候補3問が講義で公開済み（下の第1部）
多肢選択	30〜50問・60%。2025年は30問×2点＝60点、試験時間60分
2025年の論述	「地域医療の一般的な意味、四方が提唱した定義と特性について説明せよ」（候補1がそのまま出題）

第1部 論述対策（40点）

講義で公開された論述候補は次の3問。2025年は候補1がそのまま出題されたが、候補として残っている以上3問とも書けるようにしておく。答案は「一般的な意味 → 定義 → 特性・各項目の説明 → 一言のまとめ」の順で、講義スライドの語句をそのまま使うのが最も安全。

候補1：地域医療の一般的な意味、四方が提唱した定義と特性について説明せよ（2025年出題）

模範解答

「地域医療」という言葉は発言者によって意味が異なり、一般には①へき地医療（過疎地での医療）、②ある特定の地区における医療（身近な医療）、③大学病院や高次医療機関ではない医療（どこかその辺の医療）、④機能的な役割、の4つの意味で使われている。どれが正しくどれが間違っているとは言えないが、「医療」という言葉に置き換えても意味が変わらないのであれば、あえて「地域医療」と表現する必要はない。この4つはいずれも「地域」を医療を行う場所として捉えているが、もう一つ、⑤「地域そのものを一人の患者とみなして診る医療」という意味が考えられる。地域の健康寿命や要介護期間、受療行動、医師の偏在を症状として捉え、データで地域を診断し、連携や政策で治療する。個々の患者を「地域で」診るのではなく「地域を」診る医療であり、「医療」に置き換えると意味が成り立たない。三重県立一志病院の夢プロジェクト（2013年）は「地域医療とは単に地域で医療サービスを提供することではなく、保健・医療・福祉の連携の中で医療を行うことである」と定義しており、医療者以外の視点を包含する必要性が示されている。

四方は、保健（予防）を「医療のBefore」、福祉（介護）を「医療のAfter」と位置づけ、地域医療を「医療の前後との連携システム」すなわち「その地域特有の保健・医療・福祉の連携システムである」と定義した。地域包括ケアシステム（2005年介護保険法改正で登場、2011年構築義務化、2025年までに確立、中学校区単位、市町村の責務）は保健⇔医療⇔福祉の連携を具体化したものだが、現状では高齢者の医療介護連携にとどまっており、障がい者・小児・社会的弱者を含めたより包括的なものにする必要がある。

この定義から導かれる地域医療の特性は次の6つである。①地域医療は医療の一部ではなく地域の一部である。②地域医療は病院の外で果たす役割である（病院の内で実践する医療はプライマリ・ケアである）。③地域医療は受診した患者の疾病に対応することではない。④地域医療の対象は住民である（患者ではない）。⑤地域医療の実践者は必ずしも職種・専門性・所属を規定しない。⑥地域医療は都市部でも過疎地でも実践しうる。

すなわち、地域医療とは過疎地（田舎）で医療をすることではなく、その地域特有の保健・医療・福祉の連携システムである。

キーワードチェックリスト

- [ ] 一般的な意味4つ（へき地医療・特定の地区・高次医療機関ではない・機能的な役割）
- [ ] 「どれが正しいとは言えない」「医療に置換して意味が変わらないなら地域医療と言う必要はない」
- [ ] 一志病院 夢プロジェクト（2013年）の定義：保健・医療・福祉の連携の中で医療を行う
- [ ] 保健（予防）＝医療のBefore、福祉（介護）＝医療のAfter
- [ ] 四方の定義：その地域特有の保健・医療・福祉の連携システム（「地域特有」「連携システム」を落とさない）
- [ ] 特性6つ（地域の一部／病院の外／疾病対応ではない／対象は住民／職種を規定しない／都市部でも過疎地でも）
- [ ] 地域包括ケアシステムとの関係（現状は高齢者の医療介護連携のみ→もっと包括的に）
- [ ] 結論：過疎地で医療をすることではない

加点狙い：5つ目の意味を自分で考える

講義で「4つ以外に良い意味を考えられたら加点」という話があった。4つの意味はすべて「地域＝医療をする場所」である。そこを外して「地域＝診る対象」「地域＝医療を行う主体」と読み換えると、四方の特性（対象は住民、地域の一部、実践者を規定しない）とかみ合う意味が出てくる。第1候補を模範解答に⑤として組み込んである。

候補	内容	強み（なぜ点が取れそうか）
第1候補：地域を患者として診る医療（地域が対象）	地域そのものを一人の患者とみなす。健康寿命が短い・要介護期間が長い・医師が偏在しているが「症状」、ビッグデータやヘルスダイアリが「検査」、地域診断が「診断」、連携体制や政策（EBPM）が「治療」	「地域で診る」から「地域を診る」への転換で、一言で言えて印象に残る。「対象は住民である（患者ではない）」という特性、教室の研究（京都医療介護ビッグデータ、健康寿命延伸、EBPM）とそのままつながる。「医療」に置換すると成り立たない
第2候補：地域が行う医療（地域が主語）	「地域で」ではなく「地域が」医療をする。住民・家族・学校・行政・介護・医療者を含む地域全体が担い手で、医師はその一員にすぎない	「地域医療は医療の一部ではなく地域の一部」「実践者の職種・所属を規定しない」という特性、発達障害勉強会の例（教諭・保護者・市役所が担い手）と一致する
第3候補：地域をつくる医療（地域が目的）	医療の目的を病気を治すことではなく、人がその地域で暮らし続けられることに置く。病院がなくなれば人が去り、医療があれば人が残る。医療はまちづくりの手段	スライドの「自分が治した患者が生活している姿を初めて見た」というエピソードや「なっても大丈夫」という福祉の考え方と相性が良い。ただし地域振興論に寄りすぎると医療の定義から外れる
第4候補：医療提供体制・連携ネットワークとしての意味	地域医療構想・地域医療支援病院・地域医療連携推進法人など、行政・政策用語としての意味	無難で四方の定義につながるが、意外性は小さい。第1候補の「治療」の具体例として使うとよい

答案では第1候補を⑤として書き、「①〜④は地域を場所として捉えているが、⑤は地域を診る対象として捉える」と対比を明示する。そのうえで「『医療』に置き換えると成り立たないから地域医療と呼ぶ意義がある」と四方の基準に照らして一言添える。第2候補は第1候補と対にして「地域を診るのは医師だけではなく地域自身である」と続けると、「対象」と「主体」の両方で地域を読み換えた答案になる。

候補2：プライマリ・ケアの理念 ACCCA（IOM, 1978）を説明せよ

模範解答

プライマリ・ケアは日本では①初期診療（受診して最初の診療、門番的役割）、②かかりつけ医による医療（よくある疾患・慢性疾患の診療）、③大学病院や高度医療機関ではない医療、などの意味で使われ、日本プライマリ・ケア連合学会は「身近にあって、何でも相談にのってくれる総合的な医療」と簡潔に表現している。米国医学研究所（IOM）は1978年にプライマリ・ケアの理念として5つの要素 ACCCA を示し、これは世界で広く採択されている。

① Accessibility（近接性）：地理的・経済的・時間的・精神的にアクセスしやすいこと。② Comprehensiveness（包括性）：予防からリハビリテーションまで、全人的・全科的に、年齢を問わず対応すること。③ Coordination（協調性）：専門医と、チームメンバーと、住民と協調し、社会資源を活用すること。④ Continuity（継続性）：ゆりかごから墓場まで、健康な時も含めて、外来－入院－外来へと継続して関わること。⑤ Accountability（責任性）：医療内容に責任を持ち、生涯学習を続け、十分な説明を行うこと。

IOMは同年「プライマリ・ケアはケアをする場所、受けた研修、提供するサービス内容によって定義されるものではない。サービス自体がプライマリ・ケアを定義するのであり、良い医療者はあらゆる分野において養成しうる」とも述べており、換言すれば何科の医師であろうとプライマリ・ケアの実践者になれるということである。なお1996年の再定義（「個人の健康ニーズの大部分に対応し、患者との継続的なパートナーシップを築き、家族や地域の状況の中で実践することに責任をもつ臨床医による、統合されたアクセス可能な健康ケアサービスの提供」）は「臨床医による」と主体を限定しており、あまり採択されていない。

キーワードチェックリスト

- [ ] IOM（米国医学研究所）1978年、「理念」であること（Starfield は「機能」）
- [ ] A：近接性＝地理的・経済的・時間的・精神的アクセス（「診察時の距離」ではない）
- [ ] C：包括性＝予防からリハビリまで、全人的・全科的、年齢不問
- [ ] C：協調性＝専門医・チーム・住民との協調、社会資源の活用
- [ ] C：継続性＝ゆりかごから墓場まで、健康な時も、外来－入院－外来
- [ ] A：責任性＝医療内容・生涯学習・十分な説明
- [ ] 「広く採択されている」／1996年再定義は「臨床医による」で「あまり採択されていない」
- [ ] 何科の医師でもプライマリ・ケアの実践者になれる

候補3：プライマリ・ケアの機能 Barbara Starfield の 4C を説明せよ

模範解答

IOMのACCCAがプライマリ・ケアの「理念」であるのに対し、Barbara Starfield は1998年にプライマリ・ケアの「機能」を整理し、プライマリ・ケアに特有の特徴として4つのC を挙げた。① First Contact care（最初のケア）：健康問題が生じたときに最初に接触するケアであること。② Longitudinality（継続的な関係性、Continuity とも）：健康問題の有無や種類にこ

だわらず、疾患ではなく個人に焦点を当て、治療よりも問題の対処に焦点を当てた継続的な関係性。③ Comprehensiveness（包括性）：幅広い健康問題に対応すること。④ Coordination / integration of care（ケアの協調性・統合）：他の医療者やサービスと連携しケアを統合すること。

Starfield はさらに「必須だが特有ではない特徴」として、Medical record format（診療録形式）、Continuity of care（ケアの連続性）、Practitioner-patient communication（医療者－患者のコミュニケーション）、Clinical quality of care（ケアの質）、Advocacy for patients（患者のための擁護）を、「派生的な特徴」として Family centered（家族志向）、Cultural competence（文化的価値観）、Community oriented（地域志向）を挙げている。ここでの Continuity of care は「継続して診る」という意味ではなく、他のサービスへの移行を連続的に行うことを指し、4Cの Longitudinality とは区別される。

なお Saultz（1999年）は Access・Continuity・Comprehensive・Coordination・Contextual care の ACCCC を統合したところが総合診療医であり、特に最後の Contextual care（コンテクスト的なケア）が総合診療医特有の特徴だとしたが、四方はこれらを統合した医療を実践している医師は何科にもおり、コンテクストに応じたケアは総合診療医特有のものではないと述べている。

キーワードチェックリスト

- [ ] Starfield 1998年、「機能」、プライマリ・ケアの「特有の特徴」が4C
- [ ] First Contact care（最初のケア）
- [ ] Longitudinality：健康問題の有無や種類にこだわらない／疾患ではなく個人／治療より問題の対処
- [ ] Comprehensiveness（包括性）
- [ ] Coordination / integration of care（ケアの協調性・統合）
- [ ] 必須だが特有ではない特徴5つ・派生的な特徴3つ（1つずつでも挙げられると加点）
- [ ] Continuity of care ≠ 継続して診ること。他サービスへの移行を連続的に
- [ ] （余裕があれば）Saultz の ACCCC と Contextual care、四方の私見

答案の書き方

- 冒頭1文で「○○とは…である」と定義を言い切り、その後に項目を番号付きで並べる。採点者はキーワードの有無で見るので、英語名＋日本語訳＋一言の説明を5項目分そろえる。
- 年号と提唱者（IOM 1978、Starfield 1998、Saultz 1999、一志病院 2013、介護保険法改正 2005、義務化 2011、2025年）は加点要素なので入れる。
- 最後の1文は講義のメインメッセージ（「地域医療とは田舎で医療をすることではない」「地域や患者のニーズによって自らを柔軟に変化させる医師が総合診療医」）で締める。
- 再試験は論述式もしくは口頭試問なので、口頭で3分説明できる形でも練習しておく。

第2部① 2025年過去問（全文）

試験時間60分。解答・解説は講義資料と一般的な医学知識から導いたもので、公式の正答ではない。

論述（40点）

地域医療の一般的な意味、四方が提唱した定義と特性について説明せよ。

解答	解説
第1部 候補1の模範解答	「一般的な意味4つ → 一志病院の定義 → 四方の定義（その地域特有の保健・医療・福祉の連携システム） → 特性6つ → 過疎地で医療をすることではない」の順で書く

マークシート多選択肢（1問2点 30問）

問1

地域包括ケアシステムについて誤っているものはどれか。

- a 地域包括ケアシステムは2005年介護保険法改正で登場した。
- b 2011年に地域包括ケアシステム構築が義務化された。
- c 2025年までにシステムを構築することが求められた。
- d 小学校単位でのシステム構築が求められた。
- e システム構築は市町村の責務である。

解答	解説
d	小学校単位ではなく中学校区単位（おおむね30分以内にサービスが届く日常生活圏域）。2005年登場、2011年義務化、2025年確立、市町村の責務は正しい。

問2

WHOと英国のプライマリ・ヘルスケアの組み合わせで誤っているものはどれか。

- a アルマ・アタ宣言（1978） ― 公衆衛生の確保
- b “Health for All in the 21st century”（1998） ― 保健ケアの確保

- c “Primary Health Care” ── 人頭払い方式
- d アスタナ宣言（2018） ── UHCとSDGs
- e 英国国民保健サービス（1948） ── 総合診療医がファーストゲイト

解答	解説
c	「Primary Health Care - Now more than ever」（2008）は政策面での改革（UHC・サービス提供・公的政策・リーダーシップ）。人頭払い方式は英国NHS（1948）の特徴。

問3

プライマリ・ケアの理念 ACCCA（IOM, 1978）について誤っているものはどれか。

- a Accessibility とは近接性であり、診察時の距離も含まれる。
- b Comprehensiveness は包括性であり、年齢不問も含まれる。
- c Coordination は協調性であり、社会資源の活用も含まれる。
- d Continuity は継続性であり、健康の時も含まれる。
- e Accountability は責任性であり、生涯学習も含まれる。

解答	解説
a	Accessibility（近接性）は地理的・経済的・時間的・精神的アクセス。「診察時の距離」は含まない。b〜eはスライド通り。

問4

Starfield の4C（1998）について誤っているものはどれか。

- a プライマリ・ケアの機能についてまとめたものである。
- b Longitudinality は健康問題の有無や種類にこだわらない関係性である。
- c Longitudinality は疾患ではなく個人に焦点を当てる。
- d Longitudinality は治療よりも問題の対処に焦点を当てる。
- e Continuity of care は継続して治療を続けるということである。

解答	解説
e	Continuity of care は「継続して診ることではなく、他のサービスへの移行を連続的に」。b〜dは Longitudinality の説明で正しい。

問5

患者の信頼を得るために、医師が最も心掛けるべきなのはどれか。

- a 自身の感情を表さない。
- b パターナリズムの姿勢を貫く。
- c 患者の間違った解釈を医学的知識でもって理論的に是正する。
- d 患者の訴えを傾聴する。
- e 面接の手順を遵守する。

解答	解説
d	傾聴と共感が信頼関係の基本。パターナリズムや理論的是正は解釈モデルを無視する対応。

問6

医療面接における非言語的コミュニケーションはどれか。

- a 語尾まで明瞭に発音する。
- b 患者が発した言葉を繰り返す。
- c 聞き取りやすい声の大きさで話す。
- d 専門用語を用いずに治療方針を説明する。
- e 患者の訴えに応じてうなずきながら聞く。

解答	解説
e	うなずきはボディランゲージ（非言語）。発音・声の大きさは準言語、おうむ返し・語句の選択は言語的。

問7

解釈モデルを知るための質問として適切でないのはどれか。

- a「症状をあげていただけますか」
- b「どんな治療が必要になるとお考えですか」
- c「病気が治ったら生活はどう変わりますか」
- d「病気があることでどのようにお困りですか」
- e「原因について思い当たることはありませんか」

解答	解説
a	「症状を挙げて」は病歴聴取。解釈モデルは原因・期待する治療・生活への影響・困りごとを聞く。

問8

急性胆嚢炎の患者に対する早期手術と待機的手術を比較した以下のシステマティックレビュー（ランダム化比較試験のメタ解析）から図のような結果を入手した。各試験における早期群と待機群のリスク差を表すフォレストプロットであり、図Aは術後死亡率、図Bは術後合併症率に関するものである。この図の解釈として誤っているのはどれか。

図の数値（過去問の写真から読み取り。リスク差（95%CI）、重み%）

試験	図A 術後死亡率	図B 術後合併症率	重み%
Van der Linden (1970)	0.00 (-0.03, 0.03)	0.11 (0.01, 0.20)	12.6
McArthur (1975)	0.00 (-0.11, 0.11)	0.11 (-0.22, 0.44)	3.2
Lahtinen (1978)	-0.09 (-0.18, 0.00)	-0.59 (-0.75, -0.43)	9.0
Jarvinen (1980)	-0.01 (-0.05, 0.02)	-0.04 (-0.15, 0.08)	15.3
Schaefer (1980)	0.00 (-0.07, 0.07)	-0.07 (-0.33, 0.18)	5.2
Norrby (1983)	-0.02 (-0.06, 0.01)	-0.01 (-0.11, 0.10)	19.0
Lo CM (1998)	0.00 (-0.04, 0.04)	-0.16 (-0.33, 0.01)	8.5
Lai PBS (1998)	0.00 (-0.04, 0.04)	0.02 (-0.10, 0.13)	8.8
Chandler (2000)	0.00 (-0.09, 0.09)	0.00 (-0.17, 0.18)	4.3
Johansson (2003)	0.00 (-0.03, 0.03)	0.07 (-0.04, 0.19)	14.2
Overall	-0.01 (-0.03, 0.00)	-0.05 (-0.09, -0.00)	100.0

横軸の左が Favours early operation、右が Favours late operation。

- a 術後死亡率に関して各ランダム化比較試験ではいずれも統計学的有意差がない。

- b 術後死亡率に関する統合値は有意差がないものの早期群が有利である。
- c 術後合併症率に関して各ランダム化比較試験ではいずれも統計学的有意差がない。
- d 術後合併症率に関する統合値は有意差がないものの早期群が有利である。
- e 両アウトカムに関して最も影響力がある研究は1983年のものである。

解答	解説
c	図Bでは Van der Linden（1970）の CI（0.01, 0.20）と Lahtinen（1978）の CI（-0.75, -0.43）が 0 を含まず、個別試験で有意差がある。a：図Aは全試験のCIが0を含む。b：統合値 -0.01（-0.03, 0.00）は負（早期有利）だが CI が 0 を含む。d：統合値 -0.05（-0.09, -0.00）は負で早期有利。上限が -0.00 と境界上だが、元論文（Papi 2004）も「有意差なし」と結論しており出題者もその前提。e：重み最大は Norrby（1983）19.0%。有意差の判定は「CIが0をまたぐか」、影響力は「重み（四角の大きさ）」で読む。

問9

医師偏在指標について、誤っているのはどれか。

- a 京都府の医師偏在指数は全国で5位以内と上位である。
- b 京都府の2次医療圏は京都市内とそれ以外の二つのみである。
- c 京都府北部は医師不足地域である。
- d 医師偏在指標とは、医師が「多い」または「少ない」地域を客観的に把握するための指標である。
- e 京都府では京都市乙訓以外の地域は全て全国平均を下回っている。

解答	解説
b	京都府の2次医療圏は丹後・中丹・南丹・京都・乙訓・山城北・山城南の6つ。京都府全体の指標は全国上位（医師多数都道府県）だが、京都・乙訓に医師が集中し、北部（丹後など）は医師少数区域。府内の偏在が大きいことが北部キャンパス・NCLICKの背景。

問10

地域医療で求められる総合診療医像で正しいとされるものはどれか。

- a 初期救急には対応せず、高度医療に専念する。
- b 「小児は診療しません」と患者さんに伝える。
- c 指定難病の患者は診療しないようにする。
- d 地域のニーズに応じて自らを柔軟に変化させることができる。
- e 幅広い症状に対応する時間はないので、あきらめる。

解答	解説
d	自治医大 地域医療白書第3号（2012）の3項目：①幅広い症状に診療できる ②初期救急に必ず対応できる ③地域のニーズに応じて自らを柔軟に変化させられる。a・b・c・eはいずれも自分の都合で守備範囲を狭める態度で逆。

問11

診療所の総合診療医に求められる能力について誤っているのはどれか。

- a 生涯にわたって学習を継続し、研鑽を続けること
- b 基本的なプライマリケア機能
- c 家族単位でのケア
- d 高度医療体制の地域導入
- e 地域における予防医療と健康増進

解答	解説
d	診療所の総合診療医に求められるのは基本的PC機能・家族単位のケア・予防と健康増進・生涯学習。高度医療体制の導入ではない。

問12

総合診療医として、80歳の認知症患者の家族から「治療の継続について相談」された。決定の原則として最も適切なのはどれか。

- a 患者の事前指示や、推定意思を尊重する。
- b 家族の意見を優先する。
- c 医療従事者のみで判断する。

- d 経済的負担を最優先する。
- e 病院の方針に従う。

解答	解説
a	本人の事前指示（AD）・推定意思を最優先。家族は推定意思を探る協力者であって決定者ではない。

問13

症候と臓器特異性において誤っているのはどれか。

- a 症候は、それ自体に関連する臓器がある。
- b 症候によって臓器特異性の高さは変わらない。
- c 症候と臓器の関係には解剖学の知識が重要である。
- d 発熱は、臓器特異性の低い症候である。発熱の原因となる臓器は多数あるからである。
- e 血便は、臓器特異性の高い症候である。血便の原因となる臓器は大腸など限られるからである。

解答	解説
b	臓器特異性の高さは症候によって変わる（発熱は低い、血便は高い）。

問14

発症様式において誤っているのはどれか。

- a 発症様式は、疾患の病理機序に関連する。
- b 発症様式は、突然発症、急性、亜急性、慢性（緩徐進行性）などがある。
- c 突然発症という発症様式は、さらに突然発症持続と突然発症改善（発作性）に分けられ、特に前者の病理機序は血管系（出血、梗塞）、構造破綻（外傷含む）の可能性が高い。
- d 発症様式が急性である場合、病理機序は感染症（細菌やウィルスなど）である可能性は低い。
- e 発症様式が慢性（緩徐進行性）である場合、病理機序は悪性新生物、変性疾患、自己免疫疾患である可能性が高い。

解答	解説
d	急性発症は炎症・感染症の可能性が高い。突然発症＝血管・構造破綻、慢性＝腫瘍・変性・自己免疫。

問15

鑑別疾患とその想起において誤っているのはどれか。

- a 知らない疾患は、鑑別疾患として想起できない。だから知らない疾患は診断できない。
- b マルキアファーヴァ・ビニャミ病などの希少かつ緊急性が低い疾患も鑑別疾患として想起するために知識として網羅しておかなければならない。
- c 症候から臓器を、発症様式から病理機序を推測し、双方を満たす疾患を鑑別疾患として想起する。
- d 鑑別疾患の中から、最も可能性の高い疾患（most likely diagnosis）を決める。
- e 最も可能性の高い疾患（most likely diagnosis）は原則1つ、多くても2つにするのが望ましい。

解答	解説
b	希少かつ緊急性の低い疾患を網羅する必要はない。Common・Critical・Curable を優先。a は講義の趣旨をそのまま述べたもの。

問16

除外すべき疾患（rule out diagnosis）において誤っているのはどれか。

- a 除外すべき疾患は、その症候において、あり得る疾患をすべて想起する。
- b 除外すべき疾患は、可能性が高い疾患に疾患スクリプトが似ているものを想起する。
- c 除外すべき疾患は、治療介入することで予後が改善する疾患を意識して想起する。
- d 除外すべき疾患は、致死的な疾患を意識して想起する。
- e 除外すべき疾患は、緊急性の高い疾患を意識して想起する。

解答	解説
a	rule out すべき疾患は「ありうる疾患をすべて」ではなく、致死的・緊急性が高い・治療で予後が変わる・疾患スクリプトが似ているものを意識して想起。

問17

微生物と生物学的分類の組合せで正しいのはどれか。

- a クラミジア ── 細胞内寄生菌
- b マイコプラズマ ── 抗酸菌
- c トキソプラズマ ── 真菌
- d ニューモシスチス ── 原虫
- e クリプトコッカス ── 嫌気性菌

解答	解説
a	クラミジア＝偶性細胞内寄生菌。マイコプラズマ＝細胞壁を持たない細菌、トキソプラズマ＝原虫、ニューモシスチス＝真菌、クリプトコッカス＝真菌。

問18

麻疹と同様の感染経路別予防策を行うのはどれか。

- a アデノウイルス
- b A群レンサ球菌
- c 水痘帯状疱疹ウイルス
- d 多剤耐性緑膿菌（MDRP）
- e メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）

解答	解説
c	麻疹は空気予防策。同じく空気予防策は水痘・播種性帯状疱疹・結核。アデノ＝接触（＋飛沫）、A群レンサ球菌＝飛沫、MDRP・MRSA＝接触。

問19

抗菌薬が有効なのはどれか。

- a 百日咳
- b 日本脳炎
- c 伝染性紅斑
- d 突発性発疹
- e COVID-19

解答	解説
a	百日咳は細菌（マクロライド有効）。日本脳炎・伝染性紅斑（パルボウイルスB19）・突発性発疹（HHV-6/7）・COVID-19 はウイルス。

問20

今後高齢化社会における医療課題として誤っているのはどれか。

- a 心不全パンデミック
- b 老老介護や独居高齢者の増加
- c 糖尿病、COPD、癌などの慢性疾患の増加
- d 急性単一疾患のみを扱う臓器別の医療需要の増大
- e 医療と介護の複合的ニーズへの対応

解答	解説
d	課題は心不全パンデミック・老老介護・慢性疾患・医療と介護の複合ニーズ。急性単一疾患の臓器別需要増大ではない。

問21

多疾患併存患者の診療における問題点として最も適切なのはどれか。

- a 臓器別診療が連携しやすく、治療方針の統一が容易である。
- b 各専門科の治療方針が独立しており、ポリファーマシーや治療負担が増大しやすい。
- c 医療費が軽減し、患者の通院回数も減少する傾向にある。
- d 病状の全体像が単純化し、マネジメントが容易になる。
- e 社会的要因は診療にほとんど影響を与えない。

解答	解説
b	各専門科の方針が独立するとポリファーマシーと治療負担（treatment burden）が増える。

問22

多疾患併存患者に対するアプローチとしての最も適切な対応はどれか。

- a すべての疾患を一律に最優先で治療し、専門科治療を全て継続する。
- b 処方薬をそのまま維持し、専門医間の調整は行わない。
- c 生活背景や価値観を踏まえて優先順位を整理し、治療負担を最小限にする。
- d 各疾患を個別に評価せず、包括的評価は避ける。
- e 社会的支援や家族の関与は考慮しない。

解答	解説
c	生活背景・価値観を踏まえて優先順位を整理し、治療負担を最小化（患者中心の包括的評価）。

問23

次のうち、日本版ホスピタリストに求められる役割として最も不適切なのはどれか。

- a 入院患者の多疾患併存状態を俯瞰的に把握し、治療方針を総合的に決定する。
- b 医学的判断だけでなく、社会的・心理的要素を含めた包括的医療を実践する。
- c 他診療科への紹介を円滑に進め、自身の負担を軽減することを主目的とする。
- d 急性期病棟での診断・治療を中心に、多職種と連携してチーム医療を推進する。
- e 研修医教育や院内の医療の質向上活動に主体的に関与する。

解答	解説
c	他科紹介で自分の負担軽減を主目的にするのは不適切。俯瞰的把握・包括的医療・チーム医療・教育と質改善が役割。

問24

日本版ホスピタリストの働き方に関する説明として誤っているのはどれか。

- a 米国と異なり、外来と入院管理を並行して担当する形態が一般的である
- b 完全シフト制勤務を導入している病院が主流であり、2週間勤務・2週間休暇制が多い
- c 各科と協働しつつ、診療科横断的な問題に主治医として関与する
- d 医療資源の限られた環境で、現実的かつ包括的なマネジメントを行う
- e 医療の質改善（Quality Improvement）活動にも関与することが期待される

解答	解説
b	2週間勤務・2週間休暇の完全シフト制は米国型。日本では外来と入院を並行して担当する形が一般的。

問25

「日本版ホスピタリストにおける協働のあり方」として、最も適切な記述はどれか。

- a 他科やコメディカルへの依頼は、医師主導のトップダウン型で行うべきである
- b 各専門科の治療方針を調整し、患者にとっての最適解を共に模索する立場に立つ
- c 診療の調整よりも、自己の専門性確立を優先すべきである
- d コミュニケーションコストを最小化するため、関与範囲を限定するのが望ましい
- e 他科の意見は尊重するが、最終判断には関与しない方が中立的である

解答	解説
b	各専門科の方針を調整し、患者にとっての最適解を共に探る。トップダウンや関与範囲の限定は誤り。

問26

次のうち、ホスピタリストの臨床判断として不適切なのはどれか。

- a 臓器別ではなく問題別にプロブレムリストを整理して、優先順位をつけて管理する。
- b 専門科への紹介後も、全体の経過を追い総合的に方針を調整する。
- c 医学的根拠に加え、患者や家族の価値観を踏まえた方針決定を主導する。
- d 各疾患の専門的知識は不要であり、マネジメント能力のみを重視する。
- e 医学的妥当性と患者・家族の希望の両立を図る。

解答	解説
d	各疾患の専門的知識も必要。問題別プロブレムリスト・紹介後も全体を追う・価値観を踏まえた方針決定は正しい。

問27

家庭医療学において重要な考え方である、医療者が患者の思いや背景を理解し、健康問題に対して協働してゆくためのモデルのことを何というか。

- a 疾患中心の医療の技法
- b 患者中心の医療の技法
- c 医療者中心の医療の技法
- d 医療者のための医療の技法
- e Bio-Psycho-Social モデル

解答	解説
b	患者中心の医療の技法（Patient-Centered Clinical Method, Stewart ら）。BPSモデルは「生物・心理・社会」の見方であって協働の技法そのものではない。

問28

「病い（Illness）」を探るためのフレームワーク「FIFE」に含まれないのは次のうちどれか。

- a 解釈
- b 期待
- c 感情
- d 環境
- e 影響

解答	解説
d	FIFE ＝ Feelings（感情）・Ideas（解釈）・Function（影響）・Expectations（期待）。「環境」は含まない。

問29

「疾患（Disease）」と「病い（Illness）」の考え方に関して、次の患者の語りのうち「Disease」と思われるのはどれか。

- a 「風邪をうつされたと思うので抗生物質をください」
- b 「急に立ち上がったらくらっときて、貧血でしょうか」
- c 「高血圧で降圧薬を飲んでいます」
- d 「お尻からずっと血が出ていて、痔の薬がほしい」
- e 「腹痛が続いていて、父が亡くなったので膜臓癌が心配です」

解答	解説
c	「高血圧で降圧薬を飲んでいます」は医学的に定義された疾患（disease）。他は本人の解釈や不安（illness）。

問30

一般的な家族図（genogram）の書き方のうち、誤っているのはどれか。

- a 男性は□、女性は○で表される。
- b 患者本人を示す場合、記号を黒塗りにする。
- c 結婚は一重線で表される。
- d 親密な関係は二重線で表される。
- e 兄弟／姉妹では、年齢の高い方から順に左から右に並べる。

解答	解説
b	家族図で患者本人は二重線の記号（黒塗りは死亡を示すことが多い）。男性□・女性○・結婚一重線・親密は二重線・兄弟は年長が左は正しい。

第2部② 分野別要点整理

A〜E は今年の講義資料（四方スライド・丹羽ハンドアウト・UpToDate）から、F〜I は2025年に出題されたが今回資料のない分野を一般的な知識で補ったもの。該当講義の資料が配られたら F〜I はそちらを優先する。

A. 地域医療と地域包括ケアシステム（四方）

項目	要点
地域医療の4つの意味	へき地医療／特定の地区の医療／大学病院・高次医療機関ではない医療／機能的な役割
一志病院 夢プロジェクト（2013）	単に地域で医療を提供することではなく、保健・医療・福祉の連携の中で医療を行うこと
四方の定義（私見 2012、著書「地域医療学のブレイクスルー」中外医学社 2021年初版、2024年第2刷）	その地域特有の保健・医療・福祉の連携システム。保健（予防）＝医療のBefore、福祉（介護）＝医療のAfter

項目	要点
地域医療の特性6つ	医療の一部ではなく地域の一部／病院の外で果たす役割／受診した患者の疾病対応ではない／対象は住民／実践者の職種・専門性・所属を規定しない／都市部でも過疎地でも実践しうる
地域包括ケアシステム	2005年介護保険法改正で登場／2011年構築義務化／2025年までに確立（団塊の世代 S22〜24年生が後期高齢者）／中学校区単位（おおむね30分以内）／市町村の責務／次は2040年に向けて
地域包括ケアの5要素	医療・介護・住まい・生活支援・介護予防（厚労省の図）。地域包括支援センターとケアマネジャーがコーディネート
四方の批判	現状は高齢者の医療介護連携のみ。障がい者・小児・社会的弱者を含めてもっと包括的に
対象と領域の比較	プライマリ・ヘルスケア（WHO 1978）：個人・地域・国・世界／保健・医療。プライマリ・ケア（IOM 1978）：個人／医療。地域包括ケア（厚労省 2005）：高齢者・地域／医療・介護。地域医療（四方 2012）：地域／保健・医療・福祉
地域医療とプライマリ・ケアの関係	病院の内で実践する医療がプライマリ・ケア、病院の外で果たす役割が地域医療

B. プライマリ・ケア（四方）

項目	要点
日本での意味	初期診療（門番的役割）／かかりつけ医による医療／大学病院や高度医療機関ではない医療。日本PC連合学会：身近にあって何でも相談にのってくれる総合的な医療

項目	要点
WHOのPHC（プライマリ・ヘルスケア）	アルマ・アタ宣言 Health for All by the Year 2000（1978）＝公衆衛生の確保（安全な水・予防接種）。HFA21（1998）＝保健ケアの確保（人権・倫理・公平性）。Primary Health Care - Now more than ever（2008）＝政策面での改革（UHC・サービス提供・公的政策・リーダーシップ）。アスタナ宣言（2018）＝UHCとSDGs（17ゴール・169ターゲット）
英国	1948年 NHS（国民保健サービス）：人頭払い方式、GPがファーストゲイト（最初の門番）。1952年 RCGP（英国総合診療医学会）。「英国の医療は政治」
米国 IOM（1978）	理念 ACCCA：近接性・包括性・協調性・継続性・責任性（広く採択）。「場所・研修・サービス内容で定義されるものではない」→何科の医師でも実践者になれる。1996年再定義は「臨床医による」であまり採択されていない
Starfield（1998）	機能。4C＝First Contact・Longitudinality・Comprehensiveness・Coordination。必須だが特有ではない：診療録形式・Continuity of care・医療者患者コミュニケーション・ケアの質・患者の擁護。派生的：家族志向・文化的価値観・地域志向
Saultz（1999）	ACCCC＝Access・Continuity・Comprehensive・Coordination・Contextual care。最後のCが総合診療医特有としたが、四方は「特有ではない」と私見

C. 総合診療（四方）

項目	要点
総合診療医のサブタイプ	総合内科（General Internal Medicine：大〜中規模病院・内科全般・成人・内科の総合管理・日本内科学会・日本病院総合診療医学会）＝ホスピタリスト側。総合診療（General Practice：中〜小規模病院・On demand）。家庭医療（Family Medicine：小規模病院〜診療所・全科領域・全年齢・継続的ケア・日本プライマリ・ケア連合学会）＝かかりつけ医側

項目	要点
日本PC学会 6つのコアコンピテンシー	①人間中心の医療・ケア ②包括的統合アプローチ ③連携重視のマネジメント ④地域志向アプローチ ⑤公益に資する職業規範 ⑥診療の場の多様性。総合診療医はプライマリ・ケアの専門家
総合の意味	専門性を高める＝守備範囲を狭くする。総合診療医は横断的専門性。総合とは要素還元主義ではない（分化した個々の要素を理解しても全体は理解できない）
地域医療で求められる総合診療医像（自治医大 地域医療白書第3号 2012）	①幅広い症状に診療できる ②初期救急に必ず対応できる ③地域のニーズに応じて自らを柔軟に変化させられる。「できる」ではなく「やっている」が重要
メインメッセージ	自分の能力で地域のニーズに応えるのではなく、地域や患者のニーズに応じて自分の診療や活動の幅を変化させる医師が総合診療医
地域のニーズ	住民＝高額医療機器・都会と同じもの、議会＝説明しやすいこと、有識者＝数字で示せること、医療者＝自分が得意・やりたいこと。真の地域ニーズは病院の中で考えてもわからず、病院の外で活動し感じるもの（例：高校の発達障害勉強会）
五十嵐の10の軸（自治医大 五十嵐正紘）	基盤：①近接性（無差別・精神的・時間的・経済的）②日常性（頻度×重要度）。場：③全人 ④家庭 ⑤地域。実現：⑥質の保証（QOL尺度）⑦個別性 ⑧生物学的接近。役割と責任：⑨役割（道案内・弁護士・調整・聴き・説明・連絡）⑩責任（継続性・責任性・民主性）。地域医療・PC・総合診療のエッセンスを凝縮
教室の研究・教育	総合診療医学＝臨床疫学的（目の前の患者・ありふれた疾患）、地域医療学＝社会疫学的（地域社会・社会格差）。京都医療介護ビッグデータ（26市町村、EBPM）、京都府は平均寿命は長いが健康寿命は短い。NCLICK＝LIC（長期滞在型実習）＋IPE（多職種連携教育）＋CBME（地域基盤型教育）、令和9年度から拡大

D. 医療コミュニケーション（丹羽）

項目	要点
ホスピタリティ vs サービス	ホスピタリティは提供する側が主体、サービスは受ける側が主体。医療の提供はホスピタリティ（全てのクレームに隷属する義務はない）
メラビアンの法則	言語（話の内容）7%、話し方（口調・抑揚・沈黙）38%、ボディランゲージ（ジェスチャー・姿勢・表情）55%。言葉と態度が矛盾するときの実験結果
身だしなみ	ファッション＝自分を主張する自己表現、身だしなみ＝相手を受け入れる自己表現。適切かどうかは患者が決める。髪は襟にかからない・ネクタイ（クールビズ可）・白衣の前を閉じる
患者満足度	1位看護師の態度・言葉遣い（93.2%）、2位医師の態度・言葉遣い（92.9%）、3位医師の知識・技術（92.0%）。態度・言葉遣いが知識・技術より上
よくあるコミュニケーション不足（Sandars 2007）	話をさえぎる・難しい医学用語・関心や共感がない・患者の目線でない・ハンディキャップへの配慮がない・理解を確認しない・診察時間不足
医療面接の3つの目的	①患者の問題解決に必要な情報を患者の関心に沿って収集 ②意思決定・治療過程への主体的参加を促す情報提供 ③良好な治療関係を築く共感的コミュニケーション
面接の流れ	オープニング（挨拶・自己紹介・患者確認・目的と了承）→傾聴・情報収集（開かれた質問・うなずき・おうむ返し・まとめ・解釈モデル）→説明・情報提供（わかりやすい言葉・質問できる雰囲気）→問題解決（選択肢を示し自己決定を援助）→クロージング（言い残し確認・オリエンテーション・いつでも連絡可）
聴く姿勢	ペーシング（相手の雰囲気・スピード・トーンに合わせる）、ゼロポジション（先入観を持たない・途中で話し出さない・沈黙を怖がらない）、うなずき＆オウム返し（いつもの倍）、同感ではなく共感（×私も同じだからわかる ○同じじゃないけどわかる気がする）

項目	要点
非言語的コミュニケーション	うなずき・視線・姿勢・表情・距離。声の大きさ・語尾の明瞭さは準言語。おうむ返し・言葉の選び方は言語的
OPQRST	Onset（発症様式）・Palliative/Provocative（増悪寛解因子）・Quality/Quantity（性質・ひどさ）・Region/Radiation（部位・放散）・Severity/associated Symptoms（程度・随伴症状）・Time course（時間経過）。OとTが特に重要
質問のタイプ	中立型（答えが1つ：お名前は）・フォーカスした質問＝閉じた質問（Yes/No）・開かれた質問（自由）。使い方：初期は open＞focused（ラポール）、途中から focused（鑑別に向けた陽性・陰性所見）、最後は open（聞き忘れ確認）
解釈モデル	患者や医療者が考える病気の原因・病態・経過・影響・望む治療・期待の体系。4つのポイント＝解釈・期待・感情・影響。「原因は何だとお思いですか」「どんな治療をお望みですか」と開かれた質問で。ギャップがあるとトラブルのもと（両手両足のしびれの例）
認知バイアス	ヒューリスティック（経験則）・確証（都合の良い情報を集める）・正常性（都合の悪いことを過小評価）・感情・後知恵（結果で評価）・現状維持・損失回避
伝え方	ゆっくり・わかりやすい言葉（祖母に説明する感じ）・絵図・質問を促す・情報を限定し繰り返す・時に結論から。復唱法（teach-back：「ご家族に伝えるとしたらどうお話しされますか」）、Ask me 3（主な問題は？何をする必要が？なぜ重要？）
行動変容ステージ	無関心期→関心期→準備期→実行期→維持期。命令は心理的リアクタンスで反発を招く。質問で認知的不協和を気づかせる。相手を理解することから始める
多職種連携	医師はイニシアティブを求められるが、患者の前では対等

項目	要点
診療録・診療情報提供書	診療録は公文書であり契約書のようなもの（方針変更時は協議・説明・同意の過程を記載）。紹介状：基本情報・いつから何が・検査結果・考えと施行内容・診断・経過・紹介理由・説明内容。返書は「別紙の通り」だけだと心がこもっていない

E. 臨床推論（丹羽ハンドアウト＋2025年出題の考え方）

項目	要点
発症様式と病態	突然発症＝血管障害・外傷（構造破綻）、急性＝炎症・感染、潜在性・慢性（緩徐進行）＝腫瘍・変性・自己免疫、発作性＝てんかん・反射性。突然発症は「持続」と「改善（発作性）」に分けられる
診断に至るプロセス	経過×病態×臓器。症候から臓器を、発症様式から病理機序を推測し、双方を満たす疾患を鑑別として想起。知らない疾患は想起できず診断できない
症候の臓器特異性	症候には関連臓器があり、その特異性の高さは症候によって変わる。発熱＝低い、血便＝高い。解剖学の知識が重要
鑑別の分類	解剖学的部位（by systems）と病因論的分類 VINDICATE＋P：Vascular・Infection・Neoplasm・Degenerative・Intoxication・Congenital・Autoimmune・Trauma・Endocrine・Iatrogenic/Idiopathic/Inheritance・Psychogenic
3つのC	Common disease（稀な疾患をつい考えがち）・Critical disease（緊急性・ゴールデンタイム）・Curable disease（非可逆性ではないか）。急ぐものの可能性があればゆっくり問診していられない
most likely と rule out	most likely diagnosis は原則1つ、多くても2つ。rule out すべき疾患＝致死的・緊急性が高い・治療介入で予後が改善・疾患スクリプトが似ているもの。ありうる疾患をすべてではない。希少かつ緊急性の低い疾患を網羅する必要はない

項目	要点
カルテの項目	受診理由→主訴、症状の詳細→現病歴・受療歴、過去の病気→既往歴、家族の病気→家族歴、生活の状況→生活歴・社会的背景、自分の不安→解釈モデル

F. EBM・UpToDate（フォレストプロットの読み方を含む）

項目	要点
臨床疑問の3ステップ	①疑問を整理（何を知りたいか・どんな患者が対象か・判断が変わる条件）②情報を探す（疑問に合うトピックを選び、目次から該当箇所へ）③根拠を確認（対象患者・推奨の理由・参考文献・文献確認日・最終更新日）。検索して終わりではなく、根拠を読み患者に当てはまるか考える
フォレストプロット	各試験の点推定値（四角、大きさ＝重み）と横線（95%信頼区間）。最下段の菱形＝統合推定値とその95%CI。縦線＝効果なし（リスク差なら0、リスク比・オッズ比なら1）。菱形が縦線をまたぐ＝有意差なし。各試験のCIが重ならない＝異質性（I^2が高い）。重みは通常症例数・イベント数が多い試験ほど大きい
2025年の図の読み方	急性胆嚢炎の早期手術 vs 待機手術。図A（術後死亡率）はイベントが少なく各試験のCIが広く縦線をまたぎ、統合しても有意差なしと読むのが典型。「個々の試験で有意でなくても統合すると有意になりうる」「リスク差が負＝早期群で少ない」「CIが0を含めば有意差なし」が正しい読み方。「CIが広い試験ほど重みが大きい」「有意差がない＝同等と証明された」は誤り
エビデンスの階層	システマティックレビュー・メタ解析＞RCT＞コホート＞症例対照＞症例報告＞専門家意見

G. 感染症の基礎（2025年出題範囲）

項目	要点
微生物の分類	偶性細胞内寄生菌＝クラミジア・リケッチア。細胞壁を持たない細菌＝マイコプラズマ（βラクタム無効）。抗酸菌＝結核菌・非結核性抗酸菌。真菌＝カンジダ・アスペルギルス・クリプトコッカス・ニューモシスチス。原虫＝トキソプラズマ・マラリア・赤痢アメーバ・ジアルジア。嫌気性菌＝クロストリジウム・バクテロイデス
感染経路別予防策	空気予防策（N95・陰圧室）＝麻疹・水痘・播種性帯状疱疹・結核。飛沫予防策（サージカルマスク）＝インフルエンザ・マイコプラズマ・百日咳・A群レンサ球菌・髄膜炎菌・風疹・ムンプス。接触予防策（手袋・ガウン）＝MRSA・MDRP・VRE・CD・ノロ・ロタ・アデノ・疥癬
抗菌薬が有効な感染症	細菌感染のみ。百日咳（マクロライド）・マイコプラズマ・クラミジア・A群レンサ球菌。ウイルス（日本脳炎・伝染性紅斑・突発性発疹・麻疹・風疹・インフルエンザ・COVID-19）には無効（抗ウイルス薬は別）
標準予防策	すべての患者に。手指衛生・個人防護具・咳エチケット・器材の洗浄・鋭利器材の取り扱い

H. 高齢化社会・多疾患併存・日本版ホスピタリスト（2025年出題範囲）

項目	要点
高齢化社会の医療課題	心不全パンデミック・老老介護と独居高齢者の増加・慢性疾患（糖尿病・COPD・癌）の増加・医療と介護の複合ニーズ。2040年問題（高齢者数ピーク・現役世代減少）
多疾患併存（multimorbidity）	2つ以上の慢性疾患が併存。問題点：臓器別診療が並列して方針が統一されず、ポリファーマシー・治療負担・医療費・通院回数が増える。アプローチ：包括的評価、生活背景・価値観に基づく優先順位、治療負担の最小化、社会的支援と家族の関与

項目	要点
日本版ホスピタリストの役割	入院患者の多疾患併存を俯瞰し総合的に方針決定・社会的心理的要素を含む包括的医療・急性期病棟での多職種チーム医療・研修医教育と質改善（QI）。他科紹介で自分の負担軽減を主目的にするのは誤り
働き方	米国＝入院専従・完全シフト制（7 on 7 off など）。日本＝外来と入院を並行して担当、診療科横断的な問題に主治医として関与、限られた資源で現実的かつ包括的なマネジメント
協働・臨床判断	各専門科の方針を調整し患者にとっての最適解を共に探る。問題別プロブレムリストで優先順位、紹介後も全体を追う、医学的妥当性と患者・家族の希望の両立。専門的知識は必要
意思決定の原則	本人の意思＞事前指示（AD）＞推定意思（家族と探る）＞最善の利益。ACP（人生会議）を繰り返す

I. 家庭医療（2025年出題範囲）

項目	要点
患者中心の医療の技法（Stewart ら）	①健康・疾患・病い体験の探索 ②全人的理解 ③共通の理解基盤の構築 ④患者医師関係の強化。医療者が患者の思いや背景を理解し協働するモデル
Disease と Illness	Disease＝医学的に定義された疾患（高血圧・糖尿病）。Illness＝患者の病い体験・解釈（風邪をうつされた・貧血でしょうか・痔の薬がほしい・膜臓癌が心配）
FIFE	Feelings（感情）・Ideas（解釈）・Function（影響）・Expectations（期待）。丹羽ハンドアウトの「解釈モデル4つのポイント」と同じ
BPSモデル	Bio-Psycho-Social。生物学的・心理的・社会的の3層で患者を理解（Engel 1977）
家族図（genogram）	男性□・女性○・患者本人は二重線の記号・死亡は×または黒塗り・結婚は一重線・親密は二重線・離婚は線に二本の斜線・兄弟は年長が左・3世代以上を書く・同居は点線で囲む

項目	要点
家族ライフサイクル	新婚期→養育期→教育期→巣立ち期→子離れ期→老年期。各段階の健康課題を予測して介入

第2部③ 2026年予想問題（オリジナル・過去問ではない）38問

今年の講義資料（四方スライド・丹羽ハンドアウト・UpToDate）の文言から作った予想問題。実際に出題されたものではない。

地域医療（予想問1〜6）

予想問1

「地域医療」の一般的な意味として講義で挙げられていないのはどれか。

- a へき地医療
- b ある特定の地区における医療
- c 大学病院や高次医療機関ではない医療
- d 機能的な役割
- e 高度先進医療を地方で提供する医療

解答	解説
e	4つの意味に高度先進医療はない。

予想問2

四方が提唱した地域医療の定義として正しいのはどれか。

- a 過疎地で医療を提供すること
- b その地域特有の保健・医療・福祉の連携システム
- c かかりつけ医による継続的な医療
- d 市町村が運営する高齢者向け介護サービス
- e 病院の内で実践される全人的医療

解答	解説
b	四方の定義そのもの。

予想問3

地域医療の特性について誤っているのはどれか。

- a 地域医療は医療の一部ではなく地域の一部である
- b 地域医療は病院の外で果たす役割である
- c 地域医療の対象は受診した患者である
- d 地域医療の実践者は職種や所属を規定しない
- e 地域医療は都市部でも実践しうる

解答	解説
c	対象は住民（患者ではない）。

予想問4

保健・医療・福祉の関係について正しいのはどれか。

- a 保健（予防）は医療のAfterである
- b 福祉（介護）は医療のBeforeである
- c 地域医療は医療の前後との連携システムである
- d 保健の目標は「病気になっても大丈夫」である
- e 福祉の目標は「要介護にならないように」である

解答	解説
c	保健＝Before、福祉＝After。保健は「ならないように」、福祉は「なっても大丈夫」。

予想問5

地域包括ケアシステムについて正しいのはどれか。

- a 2000年の介護保険法施行と同時に登場した
- b 2011年に構築が義務化された
- c 2040年までに確立することが求められた

- d 小学校区を単位とする
- e 都道府県の責務である

解答	解説
b	2005年登場・2011年義務化・2025年確立・中学校区・市町村の責務。

予想問6

対象と領域の組合せで誤っているのはどれか。

- a プライマリ・ヘルスケア（WHO 1978） ── 対象は個人・地域・国・世界
- b プライマリ・ケア（IOM 1978） ── 領域は保健・医療・福祉
- c 地域包括ケアシステム（厚労省 2005） ── 対象は高齢者・地域
- d 地域包括ケアシステム ── 領域は医療・介護
- e 地域医療（四方 2012） ── 領域は保健・医療・福祉

解答	解説
b	IOMのプライマリ・ケアの領域は医療のみ。

プライマリ・ケア（予想問7〜14）

予想問7

WHOのプライマリ・ヘルスケアについて誤っているのはどれか。

- a アルマ・アタ宣言は1978年である
- b アルマ・アタ宣言は安全な水や予防接種など公衆衛生の確保を目指した
- c HFA21（1998）はUHCとSDGsを掲げた
- d 「Primary Health Care - Now more than ever」は2008年である
- e アスタナ宣言は2018年である

解答	解説
c	HFA21は保健ケアの確保（人権・倫理・公平性）。UHCとSDGsはアスタナ宣言。

予想問8

英国のプライマリ・ケアについて誤っているのはどれか。

- a NHSは1948年に発足した
- b GPは出来高払いで報酬を得る
- c GPがファーストゲイトである
- d RCGPは1952年に設立された
- e 英国の医療は政治と密接に関わる

解答	解説
b	人頭払い方式。

予想問9

米国医学研究所（IOM）のプライマリ・ケアについて誤っているのはどれか。

- a 1978年の定義はケアをする場所や受けた研修によって定義されるものではないとした
- b 良い医療者はあらゆる分野において養成しうる
- c 何科の医師であろうとプライマリ・ケアの実践者になれる
- d 1996年の再定義は「臨床医による」とし、世界で広く採択されている
- e ACCCAは広く採択されている

解答	解説
d	1996年再定義はあまり採択されていない。

予想問10

ACCCAについて誤っているのはどれか。

- a 近接性には経済的アクセスも含まれる
- b 包括性は成人の疾患に限定される
- c 協調性には住民との協調も含まれる
- d 継続性は外来―入院―外来への継続を含む
- e 責任性には十分な説明が含まれる

解答	解説
b	包括性は全人的・全科的・年齢を問わない。

予想問11

ACCCAの英語と日本語の組合せで正しいのはどれか。

- a Accessibility ── 包括性
- b Comprehensiveness ── 協調性
- c Coordination ── 継続性
- d Continuity ── 近接性
- e Accountability ── 責任性

解答	解説
e	A近接・C包括・C協調・C継続・A責任。

予想問12

Starfieldの4Cに含まれないのはどれか。

- a First Contact care
- b Longitudinality
- c Comprehensiveness
- d Coordination
- e Accountability

解答	解説
e	Accountability は IOM の ACCCA。

予想問13

Starfieldが「必須だがプライマリ・ケアに特有ではない特徴」としたものでないのはどれか。

- a Medical record format
- b Continuity of care
- c Practitioner-patient communication

- d Advocacy for patients
- e Community oriented

解答	解説
e	Community oriented は派生的な特徴。

予想問14

Saultz（1999）が総合診療医特有の特徴としたのはどれか。

- a Access to care
- b Continuity of care
- c Comprehensive care
- d Coordination of care
- e Contextual care

解答	解説
e	Contextual care。四方は「総合診療医特有ではない」と私見。

総合診療（予想問15〜20）

予想問15

総合診療医のサブタイプについて誤っているのはどれか。

- a 総合内科の主な活躍の場は大〜中規模病院である
- b 総合内科の主な対象年齢は成人である
- c 家庭医療の主な活躍の場は大規模病院である
- d 家庭医療に期待される役割は継続的なケアである
- e ホスピタリストは総合内科側、かかりつけ医は家庭医療側に位置する

解答	解説
c	家庭医療は小規模病院〜診療所。

予想問16

日本プライマリ・ケア連合学会の総合診療医 6つのコア・コンピテンシーに含まれないのはどれか。

- a 人間中心の医療・ケア
- b 包括的統合アプローチ
- c 臓器別専門性の追求
- d 地域志向アプローチ
- e 診療の場の多様性

解答	解説
c	6つは人間中心・包括的統合・連携重視・地域志向・公益に資する職業規範・診療の場の多様性。

予想問17

地域医療で求められる総合診療医像（自治医科大学 地域医療白書第3号）に含まれないのはどれか。

- a 幅広い症状に対して診療ができる
- b 初期救急には必ず対応できる
- c 地域のニーズに応じて自らを柔軟に変化させることができる
- d 高額医療機器を地域に導入できる
- e 「できる」ではなく「やっている」ことが重要である

解答	解説
d	3項目に高額機器はない。

予想問18

地域のニーズについて正しいのはどれか。

- a 住民が考えるニーズがそのまま真の地域ニーズである
- b 医療者の得意なことややりたいことが地域ニーズである
- c 真の地域ニーズは病院の外で活動し感じるものである
- d 有識者が数字で示せるものが地域ニーズである
- e 地域ニーズは病院内のデータ分析で把握できる

解答	解説
c	真の地域ニーズは病院の中で考えてもわからず、病院の外で活動し感じるもの。

予想問19

「五十嵐の10の軸」について誤っているのはどれか。

- a 最も重要な基盤は近接性と日常性である
- b 近接性には患者を選ばない無差別性が含まれる
- c 日常性は単純な頻度で決まる
- d 全人・家庭・地域が仕事の場である
- e 役割には患者の道案内役・弁護士役が含まれる

解答	解説
c	日常性は単純な頻度ではなく頻度×重要度（重症度・影響度）。

予想問20

総合診療の「総合」について正しいのはどれか。

- a 各臓器専門の知識を足し合わせれば総合診療になる
- b 総合とは要素還元主義ではない
- c 専門性を高めることは守備範囲を広げることと同義である
- d 総合診療医は縦断的専門性を持つ
- e 総合診療医は自分の能力の範囲で地域のニーズに応える

解答	解説
b	要素還元主義ではない。専門性を高める＝守備範囲を狭くする。総合診療医は横断的専門性。

医療コミュニケーション（予想問21〜31）

予想問21

メラビアンの法則について正しいのはどれか。

- a 話の内容が55%を占める
- b 口調や抑揚など話し方が38%を占める
- c ボディランゲージは7%にすぎない
- d 電話での会話を対象とした実験である
- e 言葉と態度が一致している場合の実験結果である

解答	解説
b	言語7%・話し方38%・ボディランゲージ55%。対面で言葉と態度が矛盾する場合の実験。

予想問22

身だしなみについて誤っているのはどれか。

- a ファッションは自分を主張する自己表現である
- b 身だしなみは相手を受け入れる自己表現である
- c 医師の身だしなみが適切かどうかは医師自身が決める
- d 患者はいつも同世代とは限らない
- e 白衣の前は閉じる

解答	解説
c	適切かどうかは患者が決める。

予想問23

受けた医療の内容別満足度で最も高いのはどれか。

- a 医師の知識・技術
- b 医師の説明のわかりやすさ
- c 看護師の態度・言葉遣い
- d 医師の投薬
- e 診療日・診療時間

解答	解説
c	1位看護師の態度・言葉遣い 93.2%、2位医師の態度・言葉遣い 92.9%、3位医師の知識・技術 92.0%。

予想問24

医療面接の目的として誤っているのはどれか。

- a 患者の問題解決に必要な情報を患者の関心に沿って収集する
- b 患者の主体的な参加を促す情報提供を行う
- c 良好な治療関係を築く共感的コミュニケーションを展開する
- d 医師が決めた治療方針を患者に承諾させる
- e 受診に至る対処行動を聴き出す

解答	解説
d	選択肢を示した上で自己決定を援助するのであって、承諾させるのではない。

予想問25

質問法について誤っているのはどれか。

- a 問診の初期は開かれた質問より始める
- b 問診の途中からは鑑別にフォーカスした質問を増やす
- c 最後は聞き忘れがないか開かれた質問で確認する
- d 「お名前は」は中立型の質問である
- e 「どのようにおなかが痛いですか」は閉じられた質問である

解答	解説
e	「どのように」は開かれた質問。閉じた質問はYes/Noで答えるもの。

予想問26

OPQRSTの組合せで誤っているのはどれか。

- a O ── 発症様式
- b P ── 増悪・寛解因子
- c Q ── 症状の性質・ひどさ
- d R ── リズム（症状の周期性）
- e T ── 時間経過

解答	解説
d	R＝Region/Radiation（部位・放散）。S＝Severity/associated Symptoms。

予想問27

共感的な返答として最も適切なのはどれか。

- a 「私も同じだからわかります」
- b 「それは可哀想ですね」
- c 「同じじゃないけどわかる気がします」
- d 「それはつらいですね」
- e 「気にしない方がいいですよ」

解答	解説
c	同感ではなく共感。受け止めた時の感情を決めつけすぎない。

予想問28

復唱法（teach-back）として適切な言い方はどれか。

- a 「では今話したことを私に説明してください」
- b 「今の説明をご家族に伝えるとしたらどんなふうにお話しされますか」
- c 「わかりましたか」
- d 「質問はありませんね」
- e 「パンフレットを読んでおいてください」

解答	解説
b	恥をかかせない言い方で、患者自身の言葉で語ってもらう。

予想問29

行動変容ステージで「痩せようかな」と考えている段階はどれか。

- a 無関心期
- b 関心期

- c 準備期
- d 実行期
- e 維持期

解答	解説
b	無関心期「どうでもいい」→関心期「痩せようかな」→準備期「ダイエットします」→実行期→維持期。

予想問30

「自分に都合の良い情報ばかりを集めてしまう」認知バイアスはどれか。

- a 正常性バイアス
- b 確証バイアス
- c 後知恵バイアス
- d 損失回避バイアス
- e 現状維持バイアス

解答	解説
b	確証バイアス。正常性＝都合の悪いことを過小評価、後知恵＝結果で評価、損失回避＝利益より損失を重視。

予想問31

診療録・診療情報提供書について誤っているのはどれか。

- a 診療録は公文書であり契約書のようなものである
- b 治療方針を変更した場合は協議・説明・同意の過程を記載する
- c 学生やレジデントのうちは簡潔に最小限だけ書く習慣をつける
- d 紹介状にはなぜ紹介したかを書く
- e 返書が「別紙サマリーの通り」だけだと心がこもっていない印象を与える

解答	解説
c	慣れるまで（特に学生・レジデントの頃）は丁寧に書く習慣を。

臨床推論・EBM（予想問32〜36）

予想問32

発症様式と病態の組合せで誤っているのはどれか。

- a 突然発症 ── 血管障害
- b 急性発症 ── 炎症
- c 潜在発症 ── 腫瘍性病変
- d 発作性 ── てんかん
- e 慢性 ── 外傷

解答	解説
e	慢性＝変性疾患。外傷は突然発症。

予想問33

鑑別診断リストを考える上での「3つのC」に含まれないのはどれか。

- a Common disease
- b Critical disease
- c Curable disease
- d Chronic disease
- e いずれも含まれる

解答	解説
d	Common・Critical・Curable。

予想問34

VINDICATEの「D」が指すのはどれか。

- a Drug
- b Degenerative
- c Dietary
- d Dermatologic
- e Developmental

解答	解説
b	Degenerative（変性）。V血管・I感染・N腫瘍・D変性・I中毒・C先天・A自己免疫・T外傷・E内分泌。

予想問35

UpToDateで臨床疑問を調べる際の姿勢として誤っているのはどれか。

- a まず何を知りたいかを言葉にする
- b どんな患者が対象かを整理する
- c 推奨の理由と参考文献を確認する
- d 文献確認日や最終更新日を確認する
- e 検索結果の最初のトピックの推奨をそのまま目の前の患者に適用する

解答	解説
e	検索して終わりではなく、根拠を読み患者に当てはまるか考える。

予想問36

フォレストプロットの読み方として誤っているのはどれか。

- a 各試験の横線は95%信頼区間を表す
- b 最下段の菱形は統合推定値を表す
- c リスク差のフォレストプロットでは縦線は0を表す
- d 信頼区間が広い試験ほど統合への重みが大きい
- e 菱形が縦線をまたぐ場合は統計学的に有意ではない

解答	解説
d	信頼区間が狭い（症例数が多い）試験ほど重みが大きい。

教室・教育（予想問37〜38）

予想問37

NCLICK（北部キャンパスの長期統合型臨床実習）について誤っているのはどれか。

- a LICでは初診時から退院後まで主治医として関わる
- b IPEでは他の職種の業務を体験し視点を学ぶ
- c CBMEでは地域特性を知り地域医療の本質を学ぶ
- d LICの特徴は単に期間が国内最長であることである
- e 令和9年度から拡大される

解答	解説
d	単に期間が国内最長ということではない。

予想問38

京都府立医科大学 総合医療・地域医療学教室の研究について誤っているのはどれか。

- a 総合診療医学の探究は臨床疫学的アプローチである
- b 地域医療学の探究は社会疫学的アプローチである
- c 京都医療介護ビッグデータ解析は府下26市町村のデータを連結する
- d 京都府は全国に比べて平均寿命も健康寿命も長い
- e EBPM（エビデンスに基づく政策立案）に貢献する

解答	解説
d	京都府は平均寿命は長いが健康寿命は短く、平均要介護期間が延伸している。

付録

年号・数字・人名の暗記表

2025年の問1〜4はこの表の数字を入れ替えて作られている。試験直前にこの表だけ見返す。

年	事項	セットで覚えるキーワード
1948	英国 NHS 発足	人頭払い・GPがファーストゲイト
1952	英国 RCGP 設立	英国総合診療医学会
1977	Engel の BPS モデル	生物・心理・社会
1978	アルマ・アタ宣言（WHO）	Health for All by the Year 2000・公衆衛生の確保

年	事項	セットで覚えるキーワード
1978	IOM の ACCCA	プライマリ・ケアの理念・広く採択
1996	IOM 再定義	「臨床医による」・あまり採択されていない
1998	HFA21（WHO）	保健ケアの確保（人権・倫理・公平性）
1998	Starfield の 4C	プライマリ・ケアの機能
1999	Saultz の ACCCC	Contextual care
2005	介護保険法改正	地域包括ケアシステム登場
2008	Primary Health Care - Now more than ever（WHO）	政策面での改革・UHC
2011	地域包括ケアシステム構築の義務化	市町村の責務
2012	四方の地域医療の定義（私見）	自治医大 地域医療白書第3号も同年
2013	三重県立一志病院 夢プロジェクト	保健・医療・福祉の連携の中で医療を行う
2018	アスタナ宣言（WHO）	UHC と SDGs（17ゴール・169ターゲット）
2021 / 2024	「地域医療学のブレイクスルー」初版／第2刷	中外医学社
2024	北部キャンパス地域医学コース開講	大学院・社会人対象
2025	地域包括ケアシステム確立の期限	団塊の世代（S22〜24生）が後期高齢者
2027（令和9）	NCLICK 拡大	福知山・綾部・舞鶴・京丹波
2040	次の目標年	高齢者数ピーク

数字で覚えるもの：メラビアン 7・38・55%、患者満足度 93.2・92.9・92.0%、地域包括ケアはおおむね30分以内・中学校区、京都ビッグデータは26市町村、コアコンピテンシー6つ、五十嵐の軸10、地域医療の特性6つ、一般的な意味4つ。

2017年過去問（旧形式）の要点

2017年は120分で4症例、各症例で「プロブレムリスト・鑑別5つと根拠・検査5つと根拠」を書かせる臨床推論型だった。現在の形式（論述1問＋多肢選択）とは異なるが、再試験の口頭試問や臨床推論の選択肢問題の思考練習には使える。

症例	要点	鑑別の考え方（発症様式×臓器×3つのC）
1．65歳女性、一過性意識消失	動悸後に失神、数分で回復、短い四肢の震え、舌咬痕・失禁なし、心筋梗塞既往、β遮断薬・ACE阻害薬内服	突然発症改善（発作性）→心原性失神（不整脈）を最優先で rule out。起立性低血圧・薬剤性・血管迷走神経性失神・てんかん・TIA。検査：心電図・ホルター・心エコ・起立試験・血糖・血算（貧血）・電解質・頭部CT
2．48歳男性、持続する前胸部痛	圧迫感・左腕と頸部へ放散・嘔吐・労作時の既往エピソード・高血圧・脂質異常・喫煙歴	急性冠症候群が most likely。rule out：大動脈解離・肺塞栓・気胸・食道破裂。その他GERD・心膜炎。検査：12誘導心電図・トロポニン・胸部X線・心エコ・Dダイマー・血算・血糖・脂質
3．85歳男性、3か月の疲労感と体重減少	心窩部痛・1か月で4kg減・ややぶんやり・右下肺野呼吸音減弱・30年の喫煙	慢性経過→悪性腫瘍を第一に。肺癌（胸水）・胃癌・膜癌・高Ca血症や低Naによる意識変容・うつ病・糖尿病・甲状腺機能異常。検査：胸部X線・CT・上部消化管内視鏡・血算・生化（Ca・Na・血糖・肝機能）・腫瘍マーカー・甲状腺機能
4．42歳女性、両側頸部リンパ節腫大（英文出題）	6か月・2cm弾性硬・無痛・脾腫あり・B症状なし・母が乳癌	リンパ腫（ホジキン・非ホジキン）・CLLを含む白血病・転移性腫瘍・サルコイドーシス・結核・HIV・膠原病。検査：血算と末梢血像・LDH・リンパ節生検・胸腹部CT・HIV・ツベルクリンやIGRA

使った資料

- 2026年11月2日 地域医療学総論（四方 哲、M4スライド 43枚）
- 2026年10月29日 医療コミュニケーション 面接から臨床推論まで（丹羽文俊、ハンドアウト 11ページ）
- その臨床疑問、UpToDateで調べてみよう（スライド 8枚）
- 2025年 総合医療学・地域医療学 過去問（論述1問＋多肢選択30問）
- 2017年度 総合診療科 定期試験 過去問（4症例）